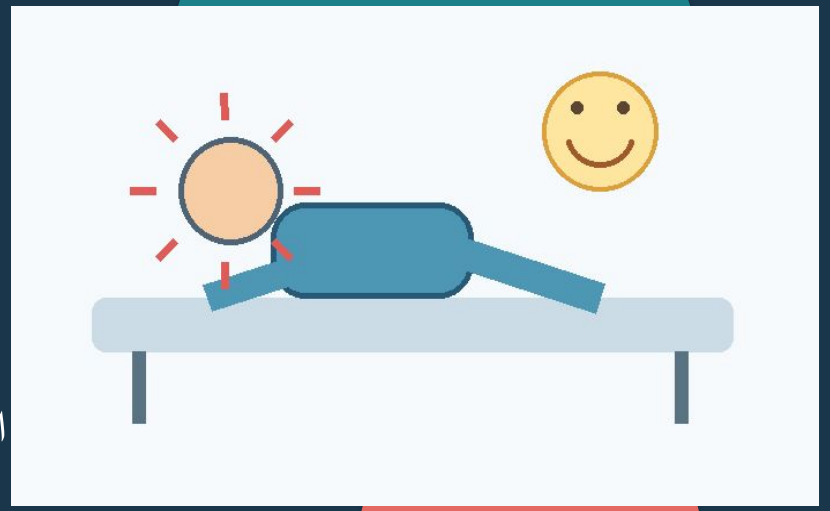
آسایش و تسکین درد

درس آموزشی ویژه دانشجویان پرستاری

ارزیابی • مداخلات دارویی و غیردارویی • فرایند پرستاری

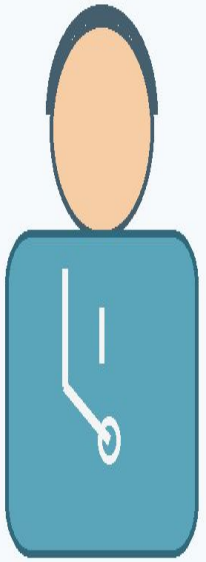


هدف: کاهش رنج بیمار، ارتقای عملکرد و حفظ کرامت انسانی

اهداف رفتاری مورد انتظار

در پایان جلسه، دانشجو بتواند:

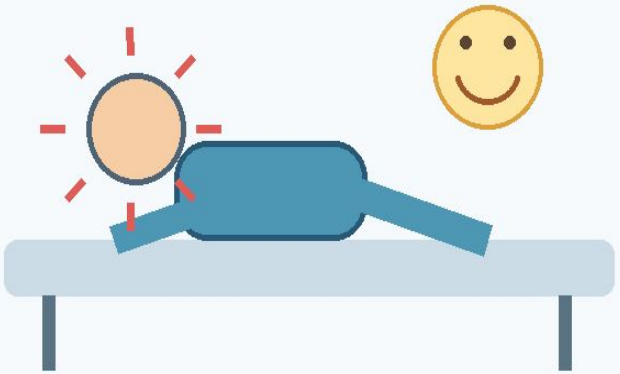
- انواع درد و تقسیم‌بندی‌های آن را توضیح دهد.
- عوامل زیستی، روانی، اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر درد را شرح دهد.
- روش‌های رایج و مختلف تسکین درد را مقایسه و توضیح دهد.
- فرایند پرستاری در ارتباط با درد را به‌صورت منظم اجرا کند.
- پاسخ بیمار به مداخله را ارزیابی و مستندسازی کند.



درد چیست؟

.درد تجربه‌ای حسی و هیجانی ناخوشایند است و همیشه فقط با آسیب بافتی برابر نیست

- درد تجربه‌ای شخصی است؛ گزارش بیمار باید جدی گرفته شود.
- شدت درد را نمی‌توان فقط از چهره، علائم حیاتی یا ظاهر بیمار نتیجه گرفت.
- درد می‌تواند وجود داشته باشد حتی اگر علت آن به‌سادگی مشخص نشود.
- هدف مراقبت: تسکین قابل‌قبول، بهبود عملکرد و کاهش رنج؛ نه صرفاً رسیدن به عدد صفر.



تقسیم‌بندی درد بر اساس مدت

مدت درد به تشخیص، درمان و برنامه مراقبتی کمک می‌کند.

درد حاد

شروع نسبتاً ناگهانی؛ معمولاً مرتبط با آسیب، جراحی یا بیماری؛ اغلب هشداردهنده است.

درد مزمن

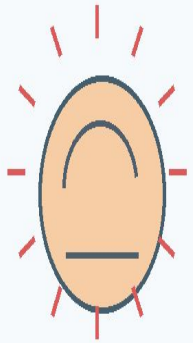
معمولاً بیش از ۳ ماه ادامه دارد یا از زمان ترمیم مورد انتظار فراتر می‌رود؛ بر خواب، خلق و عملکرد اثر می‌گذارد.

درد حاد روی مزمن

در فرد دارای درد مزمن، تشدید جدید یا یک درد حاد همزمان رخ می‌دهد؛ علت جدید باید بررسی شود.

نکته: تعریف دقیق درد مزمن و مدت آن می‌تواند با زمینه بالینی و راهنمای مورد استفاده تفاوت داشته باشد.

تقسیم‌بندی‌های دیگر درد



- از نظر محل: موضعی، منتشر، ارجاعی یا درد اندام خیالی.
- از نظر کیفیت: تیز، مبهم، فشاری، سوزشی، تیرکشنده یا ضربان‌دار.
- از نظر الگو: مداوم، متناوب، حمله‌ای یا وابسته به حرکت.
- از نظر زمینه: پس از عمل، سرطان، زایمان، آسیب، بیماری مزمن یا اقدامات درمانی.

مسیر ساده انتقال درد

از گیرنده‌های محیطی تا تفسیر مغز

۱. انتقال محیطی

آسیب یا التهاب می‌تواند گیرنده‌های درد را فعال کند.

۲. انتقال عصبی

پیام از راه اعصاب محیطی و نخاع به مسیرهای بالاتر می‌رود.

۳. پردازش مغزی

مغز پیام را با توجه به توجه، هیجان، تجربه و زمینه تفسیر می‌کند.

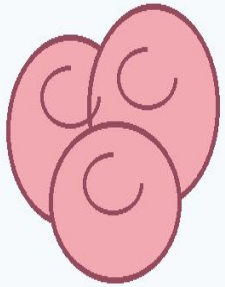
۴. پاسخ فرد

تجربه درد و پاسخ‌های رفتاری، هیجانی و جسمی شکل می‌گیرد.

درد فقط یک پیام عصبی نیست؛ تجربه‌ای چندبعدی و وابسته به فرد است.

عوامل مؤثر بر درد: زیستی

- نوع، محل و شدت آسیب یا بیماری؛ التهاب و وضعیت ترمیم بافت.
- سن و مرحله رشد؛ توانایی ارتباط و گزارش درد.
- خستگی، کم‌خوابی، گرسنگی و وضعیت عمومی بدن.
- بیماری‌های همراه، حساسیت عصبی و سابقه درد.
- داروهای مصرفی، تحمل دارویی و پاسخ فرد به درمان.



عوامل مؤثر بر درد: روانی، اجتماعی و فرهنگی

فرهنگی

باورها، زبان، شیوه ابراز درد، معنای بیماری و ترجیح‌های فردی.

اجتماعی

حمایت خانواده، تنهایی، فشارهای اقتصادی، محیط درمان و اعتماد به تیم.

روانی

اضطراب، ترس، افسردگی، توجه به درد، انتظار از درمان و تجربه‌های قبلی.

از کلیشه‌سازی پرهیز کنید: فرهنگ یا ظاهر فرد به‌تنهایی شدت درد را نشان نمی‌دهد.

ارزیابی درد: چه بپرسیم؟

.گزارش بیمار، در صورت امکان، مهم‌ترین منبع ارزیابی است



- محل: کجا درد می‌کند؟ آیا به جایی انتشار دارد؟
- شروع و زمان: از چه زمانی؟ مداوم است یا متناوب؟
- کیفیت: سوزشی، فشاری، تیرکشنده یا مبهم؟
- شدت: در مقیاس ۰ تا ۱۰، درد اکنون چقدر است؟
- عوامل تشدید/تسکین، علائم همراه و اثر بر خواب، حرکت و فعالیت.
- هدف خود بیمار از تسکین درد چیست؟

ابزارهای رایج سنجش شدت درد

مقیاس‌های رفتاری

برای نوزادان یا بیمارانی که قادر به خودگزارشی نیستند، ابزار معتبر متناسب با گروه استفاده شود.

مقیاس دیداری/کلامی

خط دیداری یا توصیف کلامی شدت درد؛ بر اساس توانایی و ترجیح بیمار انتخاب شود.

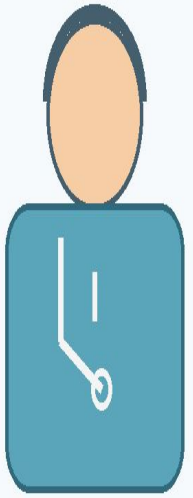
NRS مقیاس عددی

از ۰ بدون درد تا 10بدترین درد قابل تصور. برای بسیاری از بزرگسالان مناسب است.

علائم حیاتی به‌تنهایی ابزار سنجش شدت درد نیستند؛ ابزار باید متناسب با سن و وضعیت شناختی باشد.

روش‌های غیردارویی تسکین درد

- وضعیت‌دهی مناسب، حمایت از عضو و کاهش فشار روی محل درد.
- سرما یا گرما در صورت مناسب‌بودن و با رعایت موارد منع مصرف و ایمنی پوست.
- آرام‌سازی، تنفس آهسته، ذهن‌آگاهی و تصویرسازی هدایت‌شده.
- حواس‌پرتی، موسیقی، گفت‌وگو، بازی درمانی و حضور فرد حمایتی.
- ماساژ ملایم یا لمس درمانی فقط در صورت مناسب‌بودن علت درد.
- آموزش، توضیح مراحل کار و مشارکت بیمار در تصمیم‌گیری.



روش‌های دارویی تسکین درد

اوپیوئیدها

برای موارد منتخب و با تجویز و پایش دقیق؛ خطر خواب‌آلودگی، یبوست و سرکوب تنفسی دارند.

NSAIDها

مانند ایبوپروفن؛ ممکن است در دردهای التهابی مفید باشند. خطرات گوارشی، کلیوی، قلبی و خونریزی بررسی شود.

استامینوفن

برای برخی دردهای خفیف تا متوسط؛ توجه به دوز کل روزانه، بیماری کبدی و فرآورده‌های ترکیبی.

انتخاب دارو بر اساس علت درد، شدت، سابقه بیمار، تداخلات و دستورالعمل محلی است؛ خوددرمانی یا تغییر دوز توصیه نمی‌شود.

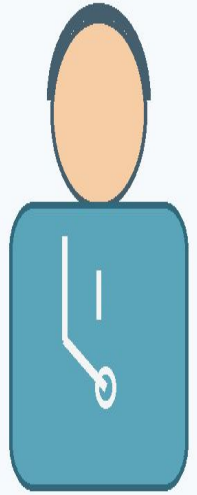
داروهای کمکی و راه‌های تجویز

- داروهای کمکی: برخی ضدافسردگی‌ها، ضدتشنج‌ها یا بی‌حس‌کننده‌های موضعی در دردهای مشخص، به‌ویژه نوروپاتیک.
- راه خوراکی معمولاً در صورت امکان ترجیح داده می‌شود؛ راه‌های دیگر بر اساس فوریت، وضعیت بیمار و دستور درمانی.
- بی‌حسی موضعی، بلوک عصبی و روش‌های منطقه‌ای ممکن است برای موارد منتخب به‌کار روند.
- پایش اثر درمان و عوارض، بخشی از تجویز ایمن است.



اصول ایمنی در تسکین دارویی

- هویت بیمار، حساسیت‌ها، دارو، دوز، راه، زمان و اندیکاسیون را بررسی کنید.
- پیش از تجویز، سطح هوشیاری، تنفس، وضعیت کلیوی/کبدی و خطرهای مرتبط را طبق دارو بسنجید.
- در اوپیوئیدها: خواب‌آلودگی غیرعادی و کاهش تنفس را جدی بگیرید؛ طبق پروتکل پایش کنید.
- تداخلات، دوزهای تکراری و داروهای ترکیبی را بررسی کنید.
- اثر و عارضه را در زمان مناسب دوباره ارزیابی و ثبت کنید.



فرایند پرستاری در ارتباط با درد

۱. ارزیابی

گزارش بیمار، ویژگی‌های درد، ابزار سنجش، عملکرد و علائم هشدار.

۲. تشخیص پرستاری

مانند درد حاد/مزمن یا اختلال در خواب و فعالیت؛ بر اساس داده‌ها و چارچوب تشخیصی محل کار.

۳. برنامه‌ریزی

هدف مشخص و قابل سنجش، زمان ارزیابی مجدد و ترجیحات بیمار.

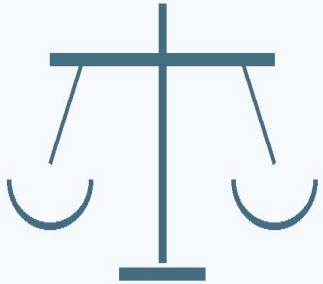
۴. اجرا

مداخلات دارویی و غیردارویی هماهنگ با برنامه درمانی.

۵. ارزیابی مجدد

مقایسه شدت درد، عملکرد و عوارض با وضعیت اولیه؛ اصلاح برنامه.

گام اول: ارزیابی جامع



- به گفته‌های بیمار گوش دهید و از سؤال‌های باز استفاده کنید.
- درد فعلی و درد در استراحت/حرکت را در صورت لزوم جداگانه ثبت کنید.
- سابقه درد، داروهای مؤثر/نامؤثر، حساسیت‌ها و عوارض قبلی را بپرسید.
- توانایی ارتباط، شناخت، زبان و نیاز به مترجم یا ابزار جایگزین را در نظر بگیرید.
- علائم هشدار را بررسی کنید: درد ناگهانی و شدید، درد قفسه سینه، علائم عصبی جدید یا ناپایداری بالینی نیازمند ارزیابی فوری است.

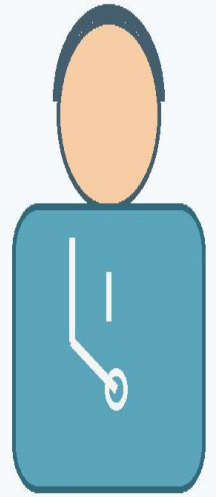
گام‌های دوم و سوم: تشخیص و برنامه‌ریزی

- تشخیص پرستاری باید از داده‌های ارزیابی پشتیبانی شود و با قالب مورد استفاده در مرکز آموزشی/درمانی هماهنگ باشد.
- هدف را با بیمار تعیین کنید؛ برای مثال: کاهش درد از ۷ به ۳ از ۱۰ طی ۶۰ دقیقه، اگر از نظر بالینی مناسب باشد.
- هدف عملکردی نیز تعریف کنید: توانایی سرفه مؤثر، تنفس عمیق، خواب یا راه‌رفتن ایمن.
- زمان ارزیابی مجدد را بر اساس دارو، راه تجویز، شدت درد و وضعیت بیمار مشخص کنید.



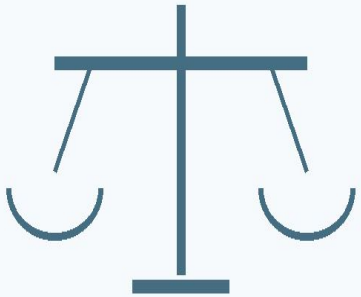
گام چهارم: اجرای مداخلات

- مداخله را توضیح دهید و رضایت و مشارکت بیمار را جلب کنید.
- اقدامات غیردارویی کم‌خطر را با علت درد و ترجیح بیمار تطبیق دهید.
- دارو را طبق دستور معتبر و اصول ایمنی تجویز کنید.
- در درد حاد پس از عمل، تسکین مناسب به تنفس عمیق، حرکت ایمن و پیشگیری از عوارض کمک می‌کند.
- در صورت ناکافی‌بودن تسکین یا بروز عارضه، موضوع را پیگیری و به تیم درمان گزارش کنید.



گام پنجم: ارزیابی مجدد و مستندسازی

- شدت درد را با همان ابزار، در زمان مناسب و در شرایط قابل مقایسه دوباره بسنجید.
- تغییر در عملکرد، خواب، حرکت و رضایت بیمار را بررسی کنید.
- عوارض احتمالی مداخله، به‌ویژه سطح هوشیاری و تنفس در درمان‌های پرخطر، ثبت شود.
- زمان، شدت قبل و بعد، مداخله، پاسخ بیمار، عوارض و اقدام بعدی مستند شود.
- اگر هدف حاصل نشد، علت را بررسی کرده و برنامه را بازنگری کنید.



ملاحظات در گروه‌های ویژه

بیماران غیرکلامی

رفتار، وضعیت بدن و تغییرات عملکرد را ارزیابی کنید؛ از مقیاس رفتاری معتبر و بررسی علت استفاده شود.

سالمندان

اختلال شناختی، شنوایی یا بینایی ممکن است گزارش درد را دشوار کند؛ مشاهده و ابزار معتبر مکمل باشند.

کودکان

از ابزار متناسب با سن استفاده کنید؛ آرام‌سازی، حضور والد و روش‌های حواس‌پرتی می‌تواند کمک‌کننده باشد.

نبودِ بیان کلامی یا رفتار آشکار به معنی نبود درد نیست.

سناریوی بالینی برای بحث کلاسی

بیمار ۵۵ ساله، دو ساعت پس از جراحی شکم، درد ۷ از ۱۰ را گزارش می‌کند. هنگام سرفه از درد می‌ترسد و تنفس عمیق را محدود کرده است.

پرسش ۱

چه اطلاعات دیگری باید ارزیابی شود؟

پرسش ۲

چه مداخلات دارویی و غیردارویی مناسب‌اند؟

پرسش ۳

چه زمانی و چگونه پاسخ بیمار را ارزیابی می‌کنید؟

یادآوری: پیش از نسبت‌دادن درد به وضعیت معمول پس از عمل، علائم هشدار و عوارض احتمالی را بررسی کنید.

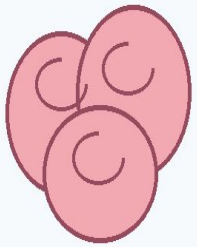
سناریو: پاسخ پیشنهادی

- ارزیابی: شدت و کیفیت درد، علائم حیاتی و وضعیت تنفسی، محل عمل، هوشیاری، داروها و حساسیت‌ها.
- مداخله: حمایت از محل برش هنگام سرفه، وضعیت‌دهی، آموزش تنفس آرام و تجویز مسکن طبق دستور.
- پایش: ارزیابی مجدد در زمان مناسب با توجه به راه تجویز و دارو؛ بررسی تنفس، هوشیاری و عوارض.
- هدف: کاهش درد تا سطح قابل‌قبول برای بیمار و بهبود توانایی تنفس عمیق و حرکت ایمن.
- در صورت درد نامتناسب، تشدید ناگهانی یا ناپایداری، ارزیابی فوری و اطلاع به تیم درمان.

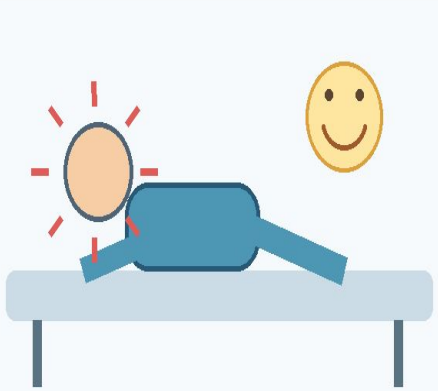


خطاهای رایج در مراقبت از درد

- قضاوت درباره درد بر اساس ظاهر بیمار یا علائم حیاتی به‌تنهایی.
- تصور اینکه همه بیماران درد را به یک شکل ابراز می‌کنند.
- تجویز دارو بدون بررسی حساسیت، تداخل، دوز یا وضعیت بیمار.
- فراموش‌کردن ارزیابی مجدد پس از مداخله.
- نادیده‌گرفتن هدف عملکردی و ترجیح بیمار.
- ثبت‌نکردن پاسخ، عوارض یا دلیل تغییر برنامه.

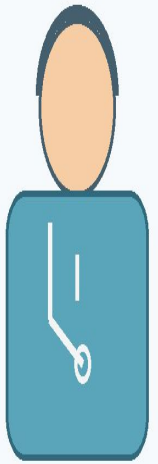


جمع‌بندی نکات کلیدی



- درد تجربه‌ای شخصی و چندبعدی است.
- درد را از نظر مدت، سازوکار، محل، کیفیت و الگو طبقه‌بندی کنید.
- ارزیابی نظام‌مند، پایه انتخاب مداخله مناسب است.
- ترکیب روش‌های دارویی و غیردارویی اغلب مفید است؛ انتخاب باید فردمحور و ایمن باشد.
- فرایند پرستاری با ارزیابی مجدد و مستندسازی کامل می‌شود.

پرسش‌های مرور



۱) سه تقسیم‌بندی مهم درد را نام ببرید.

2) چرا گزارش خود بیمار در ارزیابی درد اهمیت دارد؟

3)دو روش غیردارویی و دو گروه دارویی مورد استفاده در تسکین درد را مثال بزنید.

4)پس از تجویز مسکن، چه مواردی باید دوباره ارزیابی و ثبت شوند؟

5) در بیمار غیرکلامی چگونه درد را ارزیابی می‌کنید؟

منابع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر

- International Association for the Study of Pain (IASP): تعریف و اصطلاحات درد.
  - Raja SN, et al. The revised IASP definition of pain. Pain. 2020.
  - درسی/بالینی: اصول پرستاری و منابع معتبر ارزیابی و مدیریت درد مورد تأیید دانشگاه.
- راهنماهای محلی بیمارستان درباره تجویز ایمن مسکن‌ها، پایش اوپیوئیدها و مدیریت درد پس از عمل.
- توجه: محتوای این ارائه آموزشی است و جایگزین دستورالعمل مرکز درمانی یا قضاوت بالینی نیست.

پیشنهاد مدرس: با توجه به زمان کلاس، سناریوی بالینی و تمرین ارزیابی درد را به‌صورت گروهی اجرا کنید.